

APPENDICES

Appendix 1. Statement of Ethical Research Conduct

I hereby declare that this research titled “Dito sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas” was conducted in accordance with the guidelines set by the WHO in “Guidelines on Ethical Issues in Public Health Surveillance,” as well as applicable sections declared under the Declaration of Helsinki.

Specifically, I affirm that:

1. Participation in this study was entirely voluntary and no participant was coerced or unduly influence to partake in the research.
2. All participants were adequately informed of the purpose, procedures, potential risks, and benefits of the study prior to their participation, and informed consent was obtained.
3. Participants were assured of anonymity and confidentiality, and no personally identifiable information was collected or disclosed in any report or publication.
4. Data gathered were used solely for academic purposed and were handled, stored, and analyzed responsibly.
5. Participants were informed of their rights to withdraw from the study at any point without penalty.
6. This study did not involve procedures that posed more than minimal risk to participants.

This statement is executed in good faith in support of the submission of this thesis.

Johnson L. Santos Jr.

Researcher

Date: 13 December 2025

Institution: National College of Public Administration and Governance, UP Diliman

Appendix 2. Raw Reporting of Results from R

RQ1: First Point of Healthcare Contact Divided per Community Type

Table 1
Frequency Table of Healthcare Contact per Community Type

Platform		Community Type	% n	
			int	dbl
1	Does not consult	Non-BHS	4	3.8
2	Does not consult	BHS	3	4.4
3	BHS	Non-BHS	21	20
4	BHS	BHS	9	13.2
5	RHU	Non-BHS	29	27.6
6	RHU	BHS	17	25
7	TAM	Non-BHS	14	13.3
8	TAM	BHS	10	14.7
9	Distant public facility	Non-BHS	1	1
10	Distant public facility	BHS	0	0
11	Private facility	Non-BHS	36	34.3
12	Private facility	BHS	29	42.6

RQ2. Difference in Clinical Healthcare Reliance Divided per Community Type

Approximative General Independence Test

data: personal_illness_consult by community_type (Non-BHS, BHS)

Z = 1.8171, p-value = 0.066

alternative hypothesis: two.sided

data: fam_mem_consult by community_type (Non-BHS, BHS)

Z = 1.4171, p-value = 0.1685

alternative hypothesis: two.sided

RQ3. Predictors of Healthcare Platform Utilization Rate

Table 2
Multiple Linear Regression: BHS, RHU, TAM Models

Facility	Predictor	Term	Estimate	Std. Error	Statistic	Pr(> z)
BHS	Distance	Intercept	0.532	0.316	1.68	0.0946
BHS	Distance	BHS distance	0.148	0.108	1.37	0.171
BHS	Distance	Community type BHS	0.659	0.403	1.63	0.104
BHS	Distance	BHS distance: community type BHS	-0.114	0.135	-0.844	0.4
BHS	Waiting time	Intercept	-0.0466	0.509	-0.0916	0.927
BHS	Waiting time	BHS waiting time	0.258	0.132	1.96	0.0516
BHS	Waiting time	Community type BHS	0.0742	0.655	0.113	0.91
BHS	Waiting time	BHS waiting time: community type BHS	0.0785	0.168	0.466	0.642
BHS	Available services	Intercept	0.493	0.429	1.15	0.252
BHS	Available services	BHS available services	0.127	0.125	1.02	0.309
BHS	Available services	Community type BHS	-0.206	0.53	-0.389	0.697
BHS	Available services	BHS available services: community type BHS	0.192	0.154	1.24	0.216
BHS	Affordability	Intercept	1.11	0.307	3.6	0.0004
BHS	Affordability	BHS affordability	-0.129	0.156	-0.827	0.41
BHS	Affordability	Community type BHS	0.143	0.42	0.34	0.734
BHS	Affordability	BHS affordability: community type BHS	0.146	0.225	0.647	0.518
BHS	Awareness	Intercept	0.91	0.461	1.97	0.0501
BHS	Awareness	BHS awareness	-0.004	0.133	-0.0302	0.976

BHS	Awareness	Community type BHS	0.345	0.559	0.617	0.538
BHS	Awareness	BHS awareness: community type BHS	0.011	0.162	0.0679	0.946
BHS	Neighborhood perception	Intercept	0.871	0.618	1.41	0.161
BHS	Neighborhood perception	BHS neighborhood perception	0.0069	0.157	0.044	0.965
BHS	Neighborhood perception	Community type BHS	-0.0214	0.719	-0.0297	0.976
BHS	Neighborhood perception	BHS neighborhood perception: community type BHS	0.117	0.185	0.633	0.528
RHU	Distance	Intercept	0.99	0.34	2.91	0.0041
RHU	Distance	RHU distance	0.0377	0.0904	0.417	0.677
RHU	Distance	Community type BHS	-0.588	0.463	-1.27	0.206
RHU	Distance	RHU distance: community type BHS	0.125	0.12	1.04	0.299
RHU	Waiting time	Intercept	0.535	0.358	1.49	0.138
RHU	Waiting time	RHU waiting time	0.172	0.0963	1.78	0.0765
RHU	Waiting time	Community type BHS	-0.28	0.46	-0.609	0.544
RHU	Waiting time	RHU waiting time: community type BHS	0.0593	0.126	0.469	0.64
RHU	Available services	Intercept	0.812	0.564	1.44	0.152
RHU	Available services	RHU available services	0.0784	0.14	0.561	0.576
RHU	Available services	Community type BHS	-0.735	0.643	-1.14	0.255
RHU	Available services	RHU available services: community type BHS	0.188	0.162	1.16	0.249
RHU	Affordability	Intercept	0.774	0.3	2.58	0.0107
RHU	Affordability	RHU affordability	0.159	0.12	1.32	0.188
RHU	Affordability	Community type BHS	0.463	0.41	1.13	0.261

RHU	Affordability	RHU affordability: community type BHS	-0.254	0.158	-1.61	0.108
RHU	Awareness	Intercept	-0.153	0.485	-0.316	0.753
RHU	Awareness	RHU awareness	0.334	0.122	2.74	0.0069
RHU	Awareness	Community type BHS	-0.518	0.612	-0.847	0.398
RHU	Awareness	RHU awareness: community type BHS	0.118	0.155	0.757	0.45
RHU	Neighborhood perception	Intercept	-0.794	0.656	-1.21	0.228
RHU	Neighborhood perception	RHU neighborhood perception	0.447	0.15	2.98	0.0033
RHU	Neighborhood perception	Community type BHS	-0.0502	0.766	-0.0655	0.948
RHU	Neighborhood perception	RHU neighborhood perception: community type BHS	0.0326	0.179	0.182	0.856
TAM	Distance	Intercept	0.603	0.216	2.79	0.0059
TAM	Distance	TAM distance	0.196	0.0795	2.47	0.0147
TAM	Distance	Community type BHS	0.205	0.282	0.728	0.468
TAM	Distance	TAM distance: community type BHS	0.0141	0.107	0.132	0.895
TAM	Waiting time	Intercept	-0.218	0.413	-0.529	0.598
TAM	Waiting time	TAM waiting time	0.319	0.101	3.15	0.0019
TAM	Waiting time	Community type BHS	-0.89	0.546	-1.63	0.105
TAM	Waiting time	TAM waiting time: community type BHS	0.258	0.132	1.96	0.052
TAM	Available services	Intercept	0.277	0.371	0.747	0.456
TAM	Available services	TAM available services	0.221	0.103	2.15	0.0328
TAM	Available services	Community type BHS	-0.501	0.482	-1.04	0.3
TAM	Available services	TAM available services: community type BHS	0.2	0.133	1.51	0.133

TAM	Affordability	Intercept	1.1	0.251	4.39	0
TAM	Affordability	TAM affordability	-0.0515	0.151	-0.34	0.734
TAM	Affordability	Community type BHS	0.276	0.32	0.861	0.39
TAM	Affordability	TAM affordability: community type BHS	-0.0388	0.186	-0.208	0.835
TAM	Awareness	Intercept	0.608	0.386	1.58	0.117
TAM	Awareness	TAM awareness	0.112	0.0965	1.16	0.248
TAM	Awareness	Community type BHS	-0.651	0.501	-1.3	0.195
TAM	Awareness	TAM awareness: community type BHS	0.229	0.126	1.82	0.0707
TAM	Neighborhood perception	Intercept	-0.109	0.478	-0.229	0.819
TAM	Neighborhood perception	TAM neighborhood perception	0.274	0.111	2.46	0.0148
TAM	Neighborhood perception	Community type BHS	-1.16	0.627	-1.84	0.067
TAM	Neighborhood perception	TAM neighborhood perception: community type BHS	0.342	0.147	2.32	0.0216

RQ4. Predictors of Healthcare Platform Satisfaction Rate

Table 3
Ordinal Logistic Regression: BHS Model

Predictor	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
BHS distance	-0.08595	0.1586	-0.542	0.58787
BHS waiting time	-0.26545	0.25276	-1.05	0.29363
BHS available services	-0.24694	0.211	-1.17	0.24186
BHS affordability	0.14313	0.23103	0.62	0.53557
BHS awareness	0.20768	0.23712	0.876	0.3811
BHS neighborhood perception	0.63564	0.2463	2.581	0.00986**
Community type (BHS)	-2.85995	1.52115	-1.88	0.06009
BHS distance × community type	0.32034	0.20062	1.597	0.11032
BHS waiting time × community type	0.58601	0.32673	1.794	0.07288
BHS available services × community type	-0.05902	0.27738	-0.213	0.8315
BHS affordability × community type	0.12171	0.31511	0.386	0.6993
BHS awareness × community type	0.32199	0.2912	1.106	0.26884
BHS neighborhood perception × community type	-0.18599	0.28947	-0.643	0.52053

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
1 2	-1.0806	1.2043	-0.897
2 3	0.3022	1.1987	0.252
3 4	2.3835	1.2114	1.968
4 5	3.2268	1.2209	2.643

Table 4
Ordinal Logistic Regression: RHU Model

Predictor	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
RHU distance	-0.4425	0.17818	-2.483	0.01301*
RHU waiting time	0.59451	0.23368	2.544	0.01096*
RHU available services	0.12861	0.35098	0.366	0.71404
RHU affordability	-0.22429	0.23336	-0.961	0.33649
RHU awareness	-0.17318	0.30837	-0.562	0.5744
RHU neighborhood perception	0.99006	0.34905	2.836	0.00456**
Community type (BHS)	1.94649	1.53914	1.265	0.20599
RHU distance × community type	0.02757	0.22286	0.124	0.90155
RHU waiting time × community type	-0.03514	0.31572	-0.111	0.91137
RHU available services × community type	0.50143	0.44568	1.125	0.26056
RHU affordability × community type	-0.14467	0.29238	-0.495	0.62074
RHU awareness × community type	0.04712	0.4959	0.095	0.9243
RHU neighborhood perception × community type	-0.99386	0.49224	-2.019	0.04348*

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
1 2	0.1275	1.3024	0.098
2 3	0.8357	1.2903	0.648
3 4	3.5432	1.3163	2.692
4 5	4.6895	1.3432	3.491

Table 5
Ordinal Logistic Regression: TAM Model

Predictor	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
TAM distance	-0.20174	0.14533	-1.388	0.165
TAM waiting time	-0.032	0.35797	-0.089	0.929
TAM available services	0.48221	0.30965	1.557	0.119
TAM affordability	0.09105	0.26549	0.343	0.732
TAM awareness	0.24542	0.23967	1.024	0.306
TAM neighborhood perception	-0.08228	0.33783	-0.244	0.808
Community type (BHS)	-1.56667	1.50109	-1.044	0.297
TAM distance × community type	-0.21918	0.2064	-1.062	0.288
TAM waiting time × community type	0.44885	0.46017	0.975	0.329
TAM available services × community type	-0.43043	0.39348	-1.094	0.274
TAM affordability × community type	-0.12705	0.33099	-0.384	0.701
TAM awareness × community type	0.09373	0.31165	0.301	0.764
TAM neighborhood perception × community type	0.29251	0.45808	0.639	0.523

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
0 2	-3.9910	1.5282	-2.612
2 3	-0.9472	1.1746	-0.806
3 4	1.6720	1.1659	1.434
4 5	2.9400	1.1893	2.472

RQ5. Coping Strategies for Illness Symptoms

Table 6
Frequency Table of Coping Strategies per Community Type

Strategy		Non-BHS	BHS	
1	Cognitive reappraisal	29	54	83
2	Emotional release	36	59	95
3	Forbearance	45	79	124
4	Overactivity	32	51	83
5	Problem solving	3	23	26
6	Relaxation & recreation	39	67	106
7	Religiosity	53	87	140
8	Social support	46	82	128
9	Substance use	28	49	77

RQ6. Healthcare Delay and Avoidance

Table 7
Ordinal Logistic Regression: BHS Communities

Predictor	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Cannot afford treatment	0.3323	0.6177	0.538	0.590661
Hospital is too far	0.4703	0.6884	0.683	0.494499
Afraid to know illness	0.911	0.7526	1.21	0.22609
Afraid of huge bill	-0.8628	0.7168	-1.204	0.228691
Distrust nearby doctors	2.3356	1.0791	2.164	0.030436*
Distrust clinical medicine	-3.7413	1.0364	-3.61	0.000307***
Symptom not too serious	0.7704	0.6753	1.141	0.253916
No free time	-1.8379	0.8928	-2.059	0.039528*
Long queues	1.021	1.1254	0.907	0.364266

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
1 3	-3.4457	0.9872	-3.491
3 4	-0.2831	0.6786	-0.417
4 5	0.4710	0.6719	0.701

Table 8
Ordinal Logistic Regression: Non-BHS Communities

Predictor	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
Cannot afford treatment	1.4229	0.6161	2.31	0.0209*
Hospital is too far	0.4107	0.6668	0.616	0.5379
Afraid to know illness	-0.1767	0.6194	-0.285	0.7755
Afraid of huge bill	-0.3169	0.8197	-0.387	0.6991
Distrust nearby doctors	1.6428	1.3087	1.255	0.2094
Distrust clinical medicine	-2.1687	1.873	-1.158	0.2469
Symptom not too serious	0.6145	0.7067	0.87	0.3846
No free time	-0.4456	1.0475	-0.425	0.6705
Long queues	1.0569	0.931	1.135	0.2563

Threshold coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value
1 2	-2.0705	1.0059	-2.058
2 3	-1.6552	0.9199	-1.799
3 4	0.3946	0.7487	0.527
4 5	1.1211	0.7558	1.483

RQ7. Threshold for Health-Seeking

Table 9
Descriptive Statistics of Health-Seeking Threshold per Community Type

	Community type	n	Mean	SD	Min	Max
1	Non-BHS	105	3.52381	1.201723	1	5
2	BHS	68	3.279412	1.582041	1	5

Table 10
Frequency Table of Symptoms Observed to Consult per Community Type

	BHS	Non-BHS	Total	% n
Difficulty to move due to unbearable pain	46	77	123	71.10%
Dizziness	2	2	4	2.31%
Bad feeling	1	0	1	0.58%
Frequent illness	4	1	5	2.89%
Weakness	3	3	6	3.47%
Prolonged sickness	1	0	1	0.58%
Fainting	3	8	11	6.36%
Heaving	2	0	2	1.16%
Cough	2	1	3	1.73%
Stomach ache	1	0	1	0.58%
Headache	1	1	2	1.16%
Vomiting	2	4	6	3.47%
Difficulty to breathe	0	6	6	3.47%
Body pain	0	1	1	0.58%
Fever	0	1	1	0.58%

RQ8. Othering Index

Table 11
Reliability Statistics for Composite Othering Index

Raw α	std.alpha	G6(smc)	average_r	S/N	ase	mean	SD	median r
0.735495	0.724133	0.749199	0.396220	2.624931	0.031930	4.209538	0.883363	0.34327

Table 12
Descriptive Statistics of Composite Othering Index per Community Type

Community type		n	Mean	SD	Min	Max
1	Non-BHS	105	4.32	0.810	2.25	5
2	BHS	68	4.04	0.970	1	5

Appendix 3. Information Letters to Local Governments

The following letters were individually sent to each barangay local government units of all four communities involved in this study.



University of the Philippines
National College of Public Administration and Governance

06 Hunyo 2025

National College of Public Administration and Governance
University of the Philippines Diliman

Sa lokal na pamahalaan ng Brgy. Langka, Palayan City:

Pagbati ng kapayapaan!

Ako po si Johnson Santos, undergraduate na mag-aaral ng Public Administration, mula sa National College of Public Administration and Governance (NCPAG) sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Kasalukuyan kong isinusulat ang aking thesis na may titulong “Dito Sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Pandemic Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs).” Bahagi ng aking pag-aaral ang pagpunta sa mga GIDAs sa Nueva Ecija at mangalap ng datos tungkol sa kanilang pagpapa-gamot at pagpapa-konsulta. Gamit ang ilang metrics mula sa Department of Health GIDA Information System, napili ang inyong barangay upang mapabilang sa aking pag-aaral.

Ang liham na ito ay nagsisilbing pormal na pagpapaalam sa mga kinauukulan upang ako ay mangalap ng datos mula sa mga residente ng barangay, gayundin ang pag-bisita at pagtatanong ng ilang mga detalye tungkol sa pagpapagamot sa mga health centers at stations na malapit sa inyong barangay. Dagdag pa dito, nais din ng pag-aaral na makita ang praktika ng pagpapagamot sa mga tradisyunal na manggagamot na makikita sa barangay.

Ang pag-aaral na ito ay may endorsement ni Katuwang na Propesor Abraham Manalo, PhD at ng UP NCPAG.

Ang inyong pagpapaunlak sa pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagpapalawig ng karapatan sa kalusugan ng mga residente sa mga rural at GIDA communities sa buong Pilipinas.

Sa ngalan ng mabuting pamamahala,

Johnson Santos

Student-researcher, UP NCPAG



University of the Philippines
National College of Public Administration and Governance

09 Hunyo 2025

National College of Public Administration and Governance
University of the Philippines Diliman

Sa lokal na pamahalaan ng Brgy. Salazar, Carranglan:

Pagbati ng kapayapaan!

Ako po si Johnson Santos, undergraduate na mag-aaral ng Public Administration, mula sa National College of Public Administration and Governance (NCPAG) sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Kasalukuyan kong isinusulat ang aking thesis na may titulong “Dito Sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Pandemic Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs).” Bahagi ng aking pag-aaral ang pagpunta sa mga GIDAs sa Nueva Ecija at mangalap ng datos tungkol sa kanilang pagpapa-gamot at pagpapa-konsulta. Gamit ang ilang metrics mula sa Department of Health GIDA Information System, napili ang inyong barangay upang mapabilang sa aking pag-aaral.

Ang liham na ito ay nagsisilbing pormal na pagpapaalam sa mga kinauukulan upang ako ay mangalap ng datos mula sa mga residente ng barangay, gayundin ang pag-bisita at pagtatanong ng ilang mga detalye tungkol sa pagpapagamot sa mga health centers at stations na malapit sa inyong barangay. Dagdag pa dito, nais din ng pag-aaral na makita ang praktika ng pagpapagamot sa mga tradisyunal na manggagamot na makikita sa barangay.

Ang pag-aaral na ito ay may endorsement ni Katuwang na Propesor Abraham Manalo, PhD at ng UP NCPAG.

Ang inyong pagpapaunlak sa pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagpapalawig ng karapatan sa kalusugan ng mga residente sa mga rural at GIDA communities sa buong Pilipinas.

Sa ngalan ng mabuting pamamahala,

Johnson Santos

Student-researcher, UP NCPAG



University of the Philippines
National College of Public Administration and Governance

29 Oktubre 2025

National College of Public Administration and Governance
University of the Philippines Diliman

Sa lokal na pamahalaan ng Brgy. Palale, General Tinio:

Pagbati ng kapayapaan!

Ako po si Johnson Santos, undergraduate na mag-aaral ng Public Administration, mula sa National College of Public Administration and Governance (NCPAG) sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Kasalukuyan kong isinusulat ang aking thesis na may titulong “Dito Sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Pandemic Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs).” Bahagi ng aking pag-aaral ang pagpunta sa mga GIDAs sa Nueva Ecija at mangalap ng datos tungkol sa kanilang pagpapa-gamot at pagpapa-konsulta. Gamit ang ilang metrics mula sa Department of Health GIDA Information System, napili ang inyong barangay upang mapabilang sa aking pag-aaral.

Ang liham na ito ay nagsisilbing pormal na pagpapaalam sa mga kinauukulan upang ako ay mangalap ng datos mula sa mga residente ng barangay, gayundin ang pag-bisita at pagtatanong ng ilang mga detalye tungkol sa pagpapagamot sa mga health centers at stations na malapit sa inyong barangay. Dagdag pa dito, nais din ng pag-aaral na makita ang praktika ng pagpapagamot sa mga tradisyunal na manggagamot na makikita sa barangay.

Ang pag-aaral na ito ay may endorsement ni Katuwang na Propesor Abraham Manalo, PhD at ng UP NCPAG.

Ang inyong pagpapaunlak sa pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagpapalawig ng karapatan sa kalusugan ng mga residente sa mga rural at GIDA communities sa buong Pilipinas.

Sa ngalan ng mabuting pamamahala,

Johnson Santos

Student-researcher, UP NCPAG



University of the Philippines
National College of Public Administration and Governance

30 Oktubre 2025

National College of Public Administration and Governance
University of the Philippines Diliman

Sa lokal na pamahalaan ng Brgy. General Luna, Rizal:

Pagbati ng kapayapaan!

Ako po si Johnson Santos, undergraduate na mag-aaral ng Public Administration, mula sa National College of Public Administration and Governance (NCPAG) sa University of the Philippines (UP) Diliman.

Kasalukuyan kong isinusulat ang aking thesis na may titulong “Dito Sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Pandemic Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDAs).” Bahagi ng aking pag-aaral ang pagpunta sa mga GIDAs sa Nueva Ecija at mangalap ng datos tungkol sa kanilang pagpapa-gamot at pagpapa-konsulta. Gamit ang ilang metrics mula sa Department of Health GIDA Information System, napili ang inyong barangay upang mapabilang sa aking pag-aaral.

Ang liham na ito ay nagsisilbing pormal na pagpapaalam sa mga kinauukulan upang ako ay mangalap ng datos mula sa mga residente ng barangay, gayundin ang pag-bisita at pagtatanong ng ilang mga detalye tungkol sa pagpapagamot sa mga health centers at stations na malapit sa inyong barangay. Dagdag pa dito, nais din ng pag-aaral na makita ang praktika ng pagpapagamot sa mga tradisyunal na manggagamot na makikita sa barangay.

Ang pag-aaral na ito ay may endorsement ni Katuwang na Propesor Abraham Manalo, PhD at ng UP NCPAG.

Ang inyong pagpapaunlak sa pag-aaral na ito ay makatutulong sa pagpapalawig ng karapatan sa kalusugan ng mga residente sa mga rural at GIDA communities sa buong Pilipinas.

Sa ngalan ng mabuting pamamahala,

Johnson Santos

Student-researcher, UP NCPAG

Appendix 4. Informed Consent Form¹

PAHINTULOT NA MAKILAHOK SA PANANALIKSIK

Pamagat ng Pag-aaral: Dito Sa Amin: A Quasi-Experimental Study Tracing Post-Covid-19 Pandemic Health-Seeking Patterns in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas

Mananaliksik: Johnson Santos

Naipaunawa sa aking ang pananaliksik na ito. Nabigyan ako ng pagkakataong makapagtanong na sinagot din naman. Nauunawaan kong boluntaryo ang aking pakikilahok sa proyektong ito.

Nauunawaan kong maaari akong umatras sa kalagitnaan ng pagsasagot ng interbyu na ito. Nauunawaan kong maaari kong bawiin ang anumang impormasyong ibinigay ko nang walang anumang dahilan hangga't hindi pa nakukumpleto ang pananaliksik.

Sumasang-ayon ako sa mga sumusunod:

- Sumasang-ayon akong makibahagi sa pananaliksik na ito.
- Sumasang-ayon akong kolektahin ang aking impormasyon para sa analisis.
- Sumasang-ayon akong mapasama ang aking impormasyon sa mga pananaliksik sa hiniharap higit pa sa saklaw ng proyektong ito.

Lagda: _____

Pangalan: _____

Petsa: _____

Kung mayroong tanong, mangyaring ipagbigay-alam ito sa mananaliksik: jlsantos19@up.edu.ph

Maari ding ipaalam ang anumang tanong sa tanggapan ng yunit ng pag-aaral:

UP Diliman Pambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pangmadla at Pamamahala (NCPAG)

Address: NCPAG Bldg., Raul P. de Guzman St., UP Diliman, Quezon City 1101, Philippines

Email: ncpag_dean.upd@up.edu.ph

Telefax: (63 2) 928 3861

Trunkline: (63 2) 981 8500 loc. 4152

Website: ncpag.upd.edu.ph

¹ This ICF was adopted from the UP Diliman CSSP Ethics Review Board's ICF (Filipino version)

Appendix 5. Survey Form

The following pages show the survey form used by the researcher to collect data from residents of four identified GIDAs. The form was printed on paper then distributed one by one to randomly selected participants.

PERSONAL NA IMPORMASYON

Pangalan (opsyonal): _____

Edad: _____

1. Kasarian: ☐ Babae ☐ Lalaki
2. Trabaho: _____
3. Tinatayang buwanang kita (pumili ng isa):
 - a. Php 10,000 o mas maliit pa
 - b. Php 10,000 hanggang Php 30,000
 - c. Php 30,000 hanggang Php 50,000
 - d. Higit pa sa Php 50,000
4. Pinanaka-mataas na antas ng edukasyon
 - a. Pre-elementarya
 - b. Elementarya
 - c. High school
 - d. Bokasyonal
 - e. Kolehiyo
5. Ikaw ba ay may asawa?
 - a. Meron
 - b. Wala
6. Ikaw ba ay kabilang sa mga katutubong grupo?
 - a. Oo
 - b. Hindi
7. Ilang tao ang parte ng inyong tahanan? _____
8. Mayroon ka bang health insurance?
 - a. Meron
 - b. Wala
9. Nasubukan mo na bang magpatingin sa BHS?
 - a. Oo
 - b. Hindi
10. Nasubukan mo na bang magpatingin sa RHU?
 - a. Oo
 - b. Hindi
11. Nasubukan mo na bang magpatingin sa tradisyunal na manggagamot?
 - a. Oo
 - b. Hindi

SARILING KARANASAN SA KARAMDAMAN

1. Nagkasakit ka ba sa nakalipas na labindalawang buwan?

- a. Oo
- b. Hindi

2. Kung oo, ano ang naging sakit mo? Gaano ito kalubha sa iyong pagtataya? Lagyan ng tsek ang iyong sagot.

Anong karamdaman?	Hindi malubha	Medyo hindi malubha	Neutral	Medyo malubha	Malubha

3. Sa anong pagamutan ka nagpunta para magpagamot? Lagyan ng tsek ang iyong sagot.

Anong karamdaman?	Hindi kumonsulta	BHS	RHU	Tradisyunal na manggagamot	Pampublikong ospital	Pribadong ospital

KARANASAN SA KARAMDAMAN SA PAMILYA

4. May nagkasakit ba sa iyong pamilya sa nakalipas na labindalawang buwan?

- a. Oo
- b. Hindi

5. Kung oo, ano ang naging sakit nila? Gaano ito kalubha ayon sa iyong pagtataya? Lagyan ng tsek ang iyong sagot.

Anong karamdaman?	Hindi malubha	Medyo hindi malubha	Neutral	Medyo malubha	Malubha

6. Sa anong pagamutan sila dinala para magpagamot? Lagyan ng tsek ang iyong sagot.

Anong karamdaman?	Hindi kumonsulta	BHS	RHU	Tradisyunal na manggagamot	Pampublikong ospital	Pribadong ospital

KARANASAN SA PAGPAPAGAMOT SA BHS

7. Sa nakaraang labindalawang buwan, nakapagpatingin ka ba o ang iyong pamilya sa BHS?
- Oo
 - Hindi
8. Kung oo, ano ang dahilan? Pumili kahit gaano karami ang angkop.
- Checkup/vaccination
 - Pagbubuntis/checkup sa bagong silang/checkup sa bagong panganak na ina
 - Iniindang sintomas/sakit
 - Iba pa: _____
9. Kung oo, ilang beses? Kung hindi, isulat ang NA: _____
10. Kapag ikaw ay may sakit, iniisip mo bang magpatingin sa BHS?
- Oo
 - Hindi
11. Gaano ka nasisiyahan sa serbisyo ng BHS?
- Lubhang nasisiyahan
 - Medyo nasisiyahan
 - Neutral
 - Medyo hindi nasisiyahan
 - Lubhang hindi nasisiyahan
12. Base sa iyong karanasan sa BHS, bigyan ng grado ng pagsang-ayon ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng tsek ang kahon ng iyong sagot sa bawat pangungusap.

	Hindi sumasang-ayon	Medyo hindi sumasang-ayon	Neutral	Medyo sumasang-ayon	Sumasang-ayon
Malayo ang BHS sa amin					
Agad akong naaasikaso sa BHS					
May sapat na tao at gamit sa BHS					
Mahal magpagamot sa BHS					
Alam ko ang mga serbisyo sa BHS					
Tiwala ang aming komunidad sa BHS					

KARANASAN SA PAGPAPAGAMOT SA RHU

13. Sa nakaraang labindalawang buwan, nakapagpatingin ka ba o ang iyong pamilya sa RHU?

- a. Oo
- b. Hindi

14. Kung oo, ano ang dahilan? Pumili kahit gaano karami ang angkop.

- a. Checkup/vaccination
- b. Pagbubuntis/checkup sa bagong silang/checkup sa bagong panganak na ina
- c. Iniindang sintomas/sakit
- d. Iba pa: _____

15. Kung oo, ilang beses? Kung hindi, isulat ang NA: _____

16. Kapag ikaw ay may sakit, iniisip mo bang magpatingin sa RHU?

- a. Oo
- b. Hindi

17. Gaano ka nasisiyahan sa serbisyo ng RHU?

- a. Lubhang nasisiyahan
- b. Medyo nasisiyahan
- c. Neutral
- d. Medyo hindi nasisiyahan
- e. Lubhang hindi nasisiyahan

18. Base sa iyong karanasan sa RHU, bigyan ng grado ng pagsang-ayon ang mga sumusunod na pangungusap.

Lagyan ng tsek ang kahon ng iyong sagot sa bawat pangungusap.

	Hindi sumasang-ayon	Medyo hindi sumasang-ayon	Neutral	Medyo sumasang-ayon	Sumasang-ayon
Malayo ang RHU sa amin					
Agad akong naasikaso sa RHU					
May sapat na tao at gamit sa RHU					
Mahal magpagamot sa RHU					
Alam ko ang mga serbisyo sa RHU					
Tiwala ang aming komunidad sa RHU					

KARANASAN SA PAGPAPAGAMOT SA TRADISYUNAL NA MANGGAGAMOT

19. Sa nakaraang labindalawang buwan, nakapagpatingin ka ba o ang iyong pamilya sa RHU?

- a. Oo
- b. Hindi

20. Kung oo, ano ang dahilan? _____

21. Kung oo, anong tradisyunal na manggagamot ang iyong binisita?

- a. Hilot
- b. Tawas
- c. Albularyo
- d. Tandok
- e. Iba pa: _____

22. Ilang beses kang nagpunta sa tradisyunal na manggagamot sa nakaraang labindalawang buwan? _____

23. Kapag ikaw ay may sakit, iniisip mo bang magpatingin sa tradisyunal na manggagamot?

- a. Oo
- b. Hindi

24. Gaano ka nasisiyahan sa serbisyo ng tradisyunal na manggagamot?

- a. Lubhang nasisiyahan
- b. Medyo nasisiyahan
- c. Neutral
- d. Medyo hindi nasisiyahan
- e. Lubhang hindi nasisiyahan

25. Base sa iyong karanasan sa tradisyunal na pagamutan, bigyan ng grado ng pagsang-ayon ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng tsek ang kahon ng iyong sagot sa bawat pangungusap.

	Hindi sumasang-ayon	Medyo hindi sumasang-ayon	Neutral	Medyo sumasang-ayon	Sumasang-ayon
Malayo ang tradisyunal na manggagamot sa amin					
Agad akong naaasikaso sa tradisyunal na pagamutan					
May sapat na tao at gamit sa tradisyunal na pagamutan					
Mahal magpagamot sa tradisyunal na pagamutan					
Alam ko ang mga serbisyo sa tradisyunal na pagamutan					
Tiwala ang aming komunidad sa tradisyunal na manggagamot					

PATTERN NG PAGPAPAGAMOT

26. Sa nakaraang labindalawang buwan, nasubukan mo na bang balewalain ang nararamdaman o nakikita mong sintomas?
- Oo
 - Hindi
27. Kung oo, anong sintomas ito? _____
28. Sa iyong opinyon at karanasan, gaano dapat kalubha ang sintomas bago ka magpatingin sa pagamutan?
- Sobrang malubha
 - Medyo malubha
 - Neutral
 - Medyo hindi malubha
 - Hindi malubha
29. Anong sintomas ang dapat makita o maramdaman para masabing kailangan nang magpatingin sa pagamutan?
- _____
30. Alin sa mga sumusunod ang ginagawa mo upang balewalain ang iyong sintomas? Lagyan ng tsek lahat ng nagawa o ginagawa mo.
- ☐ Humingi ng tulong sa mga kakilala o kapamilya
 - ☐ Dumulong sa pananampalataya (nagdasal, nag-simba, nag-kumpisal, etc)
 - ☐ Tiniis ang sintomas
 - ☐ Nakipag-usap sa ibang tao (na hindi doktor o manggagamot) tungkol sa nararamdamang sintomas
 - ☐ Gumawa ng mabibigat na aktibidad upang patunayang nakakayanan ang sintomas
 - ☐ Nilibang ang sarili
 - ☐ Nag-bisyo (uminom ng alkohol na inumin, nanigarilyo, etc)
 - ☐ Sinuri ang sintomas
 - ☐ Wala, tinugunan ko agad ang sintomas
31. Bakit mo binalewala ang iyong sintomas? Lagyan ng tsek lahat ng naging rason mo.
- ☐ Hindi kaya ng sahod na magpatingin sa mga klinika o ospital
 - ☐ Masyadong malayo o mahirap puntahan ang mga klinika o ospital
 - ☐ Natatakot ako na malaman ang sakit ko
 - ☐ Natatakot akong lumobo ang aking bayarin
 - ☐ Hindi ako nagtitiwala sa mga doktor na malapit sa akin
 - ☐ Hindi ako nagtitiwala sa Western na medisina
 - ☐ Hindi naman ganoon kalubha ang sintomas ko
 - ☐ Wala akong libre oras o araw para kumonsulta
 - ☐ Mahaba ang pila sa mga klinika o ospital
32. Kung mayroon kang insurance at sakit ngayong araw, pupunta ka ba sa klinikal na pagamutan?
- Oo
 - Hindi

33. Kung mayroon kang budget at sakit ngayong araw, pupunta ka ba sa klinikal na pagamutan?

- a. Oo
- b. Hindi

34. Kapag ikaw ay may sakit, saan ka unang pumupunta upang magpagamot?

- a. Hindi nagpapatingin
- b. BHS
- c. RHU
- d. Tradisyunal na manggagamot
- e. Pampublikong ospital sa labas ng aming komunidad
- f. Pribadong ospital o klinika sa labas ng aming komunidad

PANANAW SA SISTEMA NG KALUSUGAN

35. Base sa iyong opinyon, gaano ka sumasang-ayon sa bawat pangungusap? Lagyan ng tsek ang bawat kahon ng iyong sagot.

	Hindi sumasang-ayon	Medyo hindi sumasang-ayon	Neutral	Medyo sumasang-ayon	Sumasang-ayon
Limitado ang kakayahan ko sa pagpapagamot					
Mas mainam magpagamot sa siyudad kumpara sa lugar namin					
Mas mainam kumonsulta sa siyudad kumpara sa lugar namin					
Maaasahan ko ang aming lokal na pamahalaan para sa aking pangangailangang medikal					

Appendix 6. Interview Guide

Opening Script: Magandang araw po sa inyo. Ako si Johnson Santos, pwede niyo akong tawaging Xean. Isa akong estudyante ng public administration sa UP Diliman. Ang layunin ng interview na ito ay matalakay kung paano nagpapagamot ang mga residente ng mga GIDAs katulad ng inyong pamayanan. Malaya kayong magsalita, sumang-ayon, o tumuligsa sa anumang babanggitin sa diskusyon. Walang mali o tamang sagot. Bago tayo magsimula, may mga gusto ba kayong itanong?

Questions:

1. Shared illness experience
 - a. Kapag kayo ay nagkakasakit, ano ang madalas ginagawa niyo para magpagaling?
 - b. May karanasan na ba kayo na mas pinipili ninyong hindi magpagamot kahit may nararamdamang sintomas?
2. First point of healthcare contact and community differences
 - a. Kapag kayo ay nagkakasakit, saan kayo unang pumupunta para kumonsulta? Bakit?
3. Predictors of satisfaction level and utilization rate
 - a. Ano ang karaniwang pino-problema ninyo kapag kayo ay nagpapagamot?
 - b. Anong mga problema ang kinakaharap ninyo kapag nagpapagamot sa RHU, BHS, o tradisyunal na manggagamot?
4. Coping strategies
 - a. Kapag nakakaramdam o nakakakita kayo ng sintomas ng sakit, ano ang madalas ninyong gawin upang makayanan ninyo ang inyong karamdaman?
5. Healthcare delay and avoidance
 - a. Nasubukan ninyo na bang i-delay ang pagpapagamot o pagpapatingin? Bakit?
 - b. Kapag kayo ay may sakit, pumupunta pa ba kayo sa manggagamot/doktor/BHW? Bakit?

6. Threshold for health-seeking

- a. Ano yung sintomas na kapag nakita o naramdaman niyo, sinasabi ninyo sa sarili niyong kailangan niyo nang magpatingin sa manggagamot/doktor/BHW?
- b. Gaano katagal bago kayo magpatingin sa manggagamot/doktor/BHW?

7. Othering of ill rural GIDA patient

- a. Sa inyong opinyon, may sapat bang pasilidad upang tugunan ang inyong pangangailangan sa kalusugan?
- b. Sa inyong opinyon, nabibigyan ba kayo ng atensyon ng lokal at pambansang pamahalaan upang tugunan ang inyong pangangailangan sa kalusugan?
- c. Kung magkakasakit ka ngayon at kailangan mong pumunta sa isang health facility, hihingi ka ba ng tulong sa lokal na pamahalaan?
- d. Kung magkakasakit ka ngayon at kailangan mong pumunta sa isang health facility, sa tingin mo ba ay maaalalayan ka ng lokal na pamahalaan sa iyong mga kailangan?
- e. Ano pa, sa inyong palagay, ang kailangan ng inyong komunidad at pamilya na maaaring gawin ng pamahalaan upang mapabuti ang inyong kalusugan?

Closing Script: May mga gusto pa ba kayong idagdag tungkol sa mga napag-usapan natin ngayong araw? May mga tanong ba kayo para sa akin? Muli, nais kong banggitin na maaari ninyong i-withdraw ang inyong consent sa pag-aaral anumang punto bago ito mai-publish bilang final thesis. Upang i-withdraw ang inyong consent na lumahok, maaari ninyo akong i-contact gamit ang mga detalyeng nakalagay sa inyong pinirmahang informed consent form. Maraming salamat po.

Appendix 7. Research Protocol

The conduct of this study has been mapped out in the following table, with specific stages of accomplishment detailed according to the necessary timeframe for completion.

Table 13
Protocol Calendar

Task	Week											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Development of instrument												
<i>Finalize statistical model for quantitative analysis</i>	■											
<i>Finalize method for qualitative analysis</i>	■											
<i>Finalize survey questionnaire</i>		■										
<i>Develop guided interview questions</i>		■										
Setup and plan fieldwork conduct												
<i>Profiling selected GIDAs</i>		■	■	■								
<i>Polling possible survey participants</i>		■	■	■	■							
<i>Contact barangay officials</i>			■	■	■	■						
<i>Email DOH for preliminary information</i>				■	■	■						
<i>Email DTTBs in profiled GIDAs</i>				■	■	■						
Preliminary coordination												
<i>Interview with DOH Nueva Ecija</i>					■	■						
<i>Interview with concerned municipal health officers</i>					■	■	■					
<i>Courtesy calls to barangay officials</i>					■	■	■					
Fieldwork (survey and interviews)												
<i>Brgy. Palale</i>							■	■	■			
<i>Brgy. Langka</i>							■	■	■			
<i>Brgy. Salazar</i>							■	■	■			

<i>Brgy. General Luna</i>	
Finalization	
<i>Data processing</i>	
<i>Data translation</i>	
<i>Data review</i>	
<i>Data finalization</i>	
<i>Thesis drafting</i>	
<i>Consultation with adviser</i>	
<i>Final rendering</i>	

Appendix 8. Data Frame and R Script

The investigation's data frame is accessible by request through this link: https://bit.ly/DSA_df. The script used in R for the statistical analyses is likewise available by request through this link in an .R format: https://bit.ly/DSA_Script

When reproducing the above-mentioned resources, the author request that you cite them according to the suggested format indicated in the abstract page. The author reserves all right over these resources as an individual intellectual product.

Appendix 9. Budget

A total of Php 16,500 was allotted for the conduct of this study. This amount covers the following line items, along with their corresponding amount:

Table 14
Budget Plan for the Preliminary Coordination and Fieldwork Phases

Line Item	Amount (in Php)
Transportation	12,000
Printing	1,000
Food and refreshments (for interviewees)	1,500
Overhead	2,000
Total	16,500